

Artrites e Diagnósticos Diferenciais

Na aula de hoje vamos abordar um tema fundamental em reumatologia: as artrites e seus diagnósticos diferenciais. Este assunto é extremamente cobrado em provas de residência médica, especialmente pela USP, e tem grande relevância na prática clínica do pronto atendimento.

Imagine o seguinte cenário: você está de plantão no pronto atendimento e entra Seu José, 65 anos, mancando e com dor intensa no joelho há cerca de sete dias. Ele nunca teve isso antes e agora a dor ficou tão intensa que precisou buscar atendimento. Ao exame físico, você nota sinais claros de artrite. O que fazer diante dessa situação? É exatamente isso que vamos discutir.

Abordagem Inicial das Artrites

Para pensar nos diagnósticos que envolvem artrites, precisamos caracterizar muito bem o sintoma ou sinal apresentado pelo paciente. Existem alguns critérios essenciais que devem ser avaliados sistematicamente.

Primeiramente, devemos avaliar o **número de articulações acometidas**. No quadro **poliarticular**, temos acometimento de cinco ou mais articulações. No quadro **oligoarticular**, duas a quatro articulações são afetadas. Já no quadro **monoarticular**, apenas uma articulação está comprometida.

A **simetria** do acometimento também é fundamental. Pode haver acometimento simétrico, quando os dois lados do corpo apresentam padrão semelhante, ou assimétrico, como por exemplo um tornozelo de um lado e um joelho do outro.

O **tempo de evolução** é outro parâmetro crucial. As artrites agudas apresentam tempo de evolução menor que seis semanas, enquanto as crônicas evoluem por período superior a seis semanas. Vale ressaltar que esse corte temporal de seis

semanas é extremamente importante para o diagnóstico diferencial e é frequentemente cobrado em provas.

Por fim, devemos questionar o **padrão evolutivo** da artrite. Ela pode ter padrão aditivo, somando cada vez mais articulações ao longo do tempo, ou padrão migratório, acometendo determinado local, melhorando espontaneamente e depois surgindo em outro local.

Pegadinha de prova: Muitas questões tentam confundir o candidato misturando características de diferentes tipos de artrite. Memorize que a artrite reumatoide tem padrão aditivo, enquanto a febre reumática tem padrão migratório.

Classificação das Artrites por Padrão Clínico

Conhecendo e questionando esses padrões da artrite, conseguimos direcionar o raciocínio para os principais diagnósticos diferenciais de forma sistemática.

Quando estamos diante de uma **poliartrite simétrica**, com acometimento de cinco ou mais articulações de maneira semelhante nos dois lados do corpo, devemos pensar prioritariamente em dois diagnósticos se o quadro for erosivo: **artrite reumatoide** e **artrite psoriásica**. Num quadro não erosivo de poliartrite simétrica, pensamos principalmente nas **colagenoses**.

Nos quadros de **oligoartrite**, com menos de quatro articulações acometidas de maneira assimétrica, podemos estar diante de uma **espondiloartrite** ou de uma **osteoartrite**.

Já as **monoartrites** devem ser diferenciadas principalmente pelo tempo de evolução. As monoartrites agudas envolvem principalmente **artrites microcristalinas** como gota e pseudogota (doença por depósito de pirofosfato de cálcio, também chamada de CPPD), além da temida **artrite séptica**. As monoartrites crônicas geralmente correspondem à **osteoartrite**.

Comentário crítico: A artrite séptica é uma emergência reumatológica. Diante de qualquer monoartrite aguda, especialmente se acompanhada de febre, a artrite séptica deve ser descartada com urgência através da punção articular, pois o retardo no diagnóstico pode levar à destruição articular irreversível em questão de horas.

Artrite Reumatoide

A artrite reumatoide é a principal doença inflamatória de acometimento articular. Acomete principalmente mulheres numa proporção de três para um, numa faixa etária entre 40 e 60 anos.

Fisiopatologia

Para entender como ocorre a doença, precisamos compreender sua fisiopatologia. Na maioria dos casos há forte associação com exposição ao **tabagismo**, porque esse hábito promove a **citrulinização das proteínas** do corpo. Essas proteínas citrulinadas passam a ser reconhecidas como estranhas pelo sistema imune e são apresentadas aos linfócitos T, que se diferenciam em vias que promovem dano celular.

Temos a via **TH1, TH2 e TH17**, sendo esta última diretamente relacionada com a ativação dos linfócitos B. Os linfócitos B são responsáveis pela produção dos **autoanticorpos**, por isso a doença pode estar associada à positividade para **fator reumatoide** e para **anticorpo anti-CCP** (anticorpo contra proteínas citrulinadas). Nesse mecanismo também há participação da via do **linfócito T regulador**.

Mnemônico: Para lembrar a fisiopatologia: "**CITB**" - **CIT**rulinização → **T** helper → linfócito **B** → autoanticorpos.

Manifestações Clínicas

Em relação às manifestações clínicas da artrite reumatoide, temos uma **poliartrite crônica** (evolução maior que seis semanas), de caráter **simétrico** e acometimento

periférico. É raro haver acometimento axial, e quando ocorre é na região cervical, especificamente na articulação **atlantoaxial**, que é uma articulação sinovial. Entretanto, regiões sacroilíacas e outras porções da coluna não são acometidas.

Quando suspeitamos de artrite antes mesmo do exame físico? O paciente relata dor articular, edema das articulações (principalmente mãos), dificuldade de fechar a mão e **rigidez matinal maior que uma hora**. Geralmente essas são as características encontradas e questionadas para diferenciar de artralguas simples ou artrites não inflamatórias.

Ponto crucial para o diagnóstico: A artrite reumatoide **poupa interfalangiana distal**. Ela acomete as **metacarpofalangianas e interfalangianas proximais**, mas poupa as interfalangianas distais. Isso é fundamental para o diagnóstico diferencial com artrite psoriásica, que também pode ser erosiva mas que acomete as interfalangianas distais.

Pegadinha de prova: Para fechar o diagnóstico é fundamental encontrar artrite ao exame físico. Não é possível fechar diagnóstico de artrite reumatoide apenas com relato do paciente, sem achado ao exame físico. A artrite deve ser documentada objetivamente.

Manifestações Extra-Articulares

A artrite reumatoide pode cursar com manifestações extra-articulares em até 40% dos casos. Podem surgir **nódulos reumatoides** no tecido celular subcutâneo, principalmente em áreas extensoras, e também nas regiões periféricas dos pulmões.

Pode haver acometimento ocular com **conjuntivite seca, esclerite e episclerite**. Do ponto de vista pulmonar, pode cursar com **doença intersticial pulmonar**, sendo o achado mais comum a **pneumonia intersticial usual**. Do ponto de vista hematológico, pode cursar com anemia, trombocitose e até alterações dos linfócitos.

Exemplo clínico: Um paciente tabagista com artrite reumatoide desenvolve nódulos pulmonares na tomografia. Esses nódulos podem ser grandes e formar massas, facilmente confundidos com neoplasia pulmonar, especialmente considerando o tabagismo. Nesses casos, frequentemente é necessária biópsia para diagnóstico diferencial.

Algumas tríades são frequentemente cobradas em provas. A **Síndrome de Felty** caracteriza-se pela tríade: artrite reumatoide associada a esplenomegalia e neutropenia. A fisiopatologia ainda é obscura, mas acredita-se em sobreposição com doença linfoproliferativa.

A **Síndrome de Caplan** ocorre quando um paciente com artrite reumatoide é exposto a poeira inorgânica, incluindo sílica (geralmente uma exposição ocupacional), e desenvolve nódulos pulmonares. Esses nódulos são histologicamente diferentes dos nódulos reumatoides comuns, podendo exigir biópsia para diferenciação.

Exames Laboratoriais

Nos exames laboratoriais, há aumento importante de **provas inflamatórias** (VHS e PCR). A dosagem de autoanticorpos pode ser realizada. O **anti-CCP** tem alta especificidade; quando positivo em paciente com artrite clínica, praticamente confirma o diagnóstico de artrite reumatoide.

O **fator reumatoide** pode estar presente em outras doenças, como síndrome de Sjögren, sendo menos específico. A ausência dos anticorpos não exclui o diagnóstico; existe a **artrite reumatoide soronegativa**, geralmente com doença mais branda e menos erosiva.

Pegadinha de prova: Fator reumatoide e anti-CCP negativos NÃO excluem diagnóstico de artrite reumatoide! O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado no padrão de acometimento articular.

Exames de Imagem

Além da história clínica e exames laboratoriais, os exames de imagem auxiliam muito, principalmente em casos mais avançados, quando já existem erosões e deformidades.

Na **radiografia**, encontramos: **osteopenia periarticular**, **erosões marginais** (consideradas o padrão típico), redução ou destruição da cartilagem e, consequentemente, **deformidades articulares** pela destruição progressiva.

Em casos avançados sem tratamento adequado, podemos ver deformidades articulares importantes e agressivas. Pacientes que ficam anos sem diagnóstico ou tratamento podem evoluir com quadro articular grave, com formação de deformidades significativas que comprometem a função e qualidade de vida.

Critérios Diagnósticos

Pensamos em artrite reumatoide quando há **poliartrite simétrica e erosiva**, como podemos ver nas radiografias típicas, **com ou sem presença de autoanticorpos**, e **ausência de diagnóstico alternativo mais provável**. Por isso é tão importante exercitar os diagnósticos diferenciais diante de qualquer artrite inflamatória.

Tratamento

Em relação ao tratamento, costumamos utilizar de primeira linha, quando não há contraindicação, o **metotrexato** (MTX). A dose do comprimido é de 2,5 mg e podemos utilizar doses de 10 a 25 mg. É fundamental lembrar que é um comprimido tomado **uma vez por semana** - todos os comprimidos são tomados no mesmo dia, repetindo semanalmente.

É necessário fazer o uso de **ácido fólico 5mg no dia seguinte**, geralmente para evitar os efeitos colaterais do metotrexato, principalmente no trato gastrointestinal, e também para evitar complicações hematológicas como pancitopenia.

Das outras **medicações modificadoras de doença sintética (DMARDs)**, temos também a leflunomida, a sulfassalazina e a hidroxicloroquina. Na prática clínica, as mais utilizadas são o metotrexato e a leflunomida pelo maior potencial de ação.

Estratégia de escalonamento: Costumamos introduzir o metotrexato e reavaliar o paciente em três meses. Se o paciente persiste com atividade de doença (geralmente avaliamos através do score clínico SDAI e provas inflamatórias), associamos outro DMARD sintético, geralmente a leflunomida. O paciente é novamente reavaliado em três meses e, se mantém sinais de atividade, iniciamos terapia biológica.

Alguns guidelines, principalmente o europeu e o americano, já propõem que na falha do primeiro DMARD sintético você já associe uma terapia biológica diretamente.

Os principais **biológicos** utilizados na artrite reumatoide são da classe dos **anti-TNFs**: infliximab, adalimumab, etanercepte, certolizumab e golimumab. Podemos utilizar também os **anti-interleucina 6** como tocilizumab.

Os **inibidores da JAK** (Janus quinase) têm a vantagem de serem medicamentos via oral: upadacitinibe, tofacitinibe e baracitinibe. Como são medicamentos orais, não são considerados imunobiológicos stricto sensu, mas sim terapia avançada ou terapia alvo, embora façam parte do segundo passo no escalonamento do tratamento.

Para casos mais graves e refratários, temos o **rituximab**, que é um anti-CD20 responsável pela depleção dos linfócitos B (que estão associados à fisiopatologia que mencionamos anteriormente), e o **abatacepte**, que é um bloqueador da coestimulação do linfócito T.

Espondiloartrites

As espondiloartrites formam um grupo de doenças imunomediadas que têm patogênese e características clínicas semelhantes. Dentro deste grupo temos: espondiloartrite axial e/ou periférica, artrite enteropática, artrite psoriásica e artrite

reativa. Elas possuem características clínicas em comum, mas também têm particularidades específicas.

Manifestações Clínicas Gerais

De maneira geral, todas podem se apresentar com **acometimento axial** de qualquer extensão da coluna e das sacroilíacas. Manifestam-se com **dor na coluna de característica inflamatória** - aquela que piora ao repouso, melhora com movimentação e está associada a rigidez matinal superior a uma hora.

Quando há acometimento da coluna cervical, torácica ou lombar, denominamos **espondilite**. Quando há acometimento das sacroilíacas, denominamos **sacroileíte**.

Todas podem se manifestar com quadro periférico de **artrite** (inflamação das articulações), **entesite** (inflamação dos pontos de inserção dos tendões nos ossos) e **dactilite** (inflamação de todo o dedo, caracterizando o "dedo em salsicha").

De manifestações extra-articulares, podem cursar com **uveíte**.

Comentário crítico: Em muitos casos, dor lombar crônica é muito comum e é difícil, apenas com história clínica, diferenciar um quadro inflamatório de um quadro mecânico. Por isso, podemos lançar mão de exames de imagem, principalmente **ressonância magnética**, que consegue avaliar se há presença de edema ósseo e sua localização, permitindo diferenciar quadros mecânicos de inflamatórios. Nos quadros periféricos com suspeita de entesite, utilizamos o **ultrassom reumatológico**.

Classificação das Espondiloartrites

As espondiloartrites podem ter manifestações axiais e/ou periféricas. Se temos esse quadro axial e/ou periférico associado e mais nada, estamos diante das **espondiloartrites axiais e/ou periféricas** propriamente ditas.

Quando há esse acometimento axial associado ou não ao periférico **na presença de doença inflamatória intestinal** (doença de Crohn ou retocolite ulcerativa), estamos diante da **artrite enteropática**.

Quando há acometimento axial e/ou periférico associado a **psoríase cutânea**, estamos diante da **artrite psoriásica**.

Por último, quando há acometimento axial e/ou periférico associado a **infecção** (seja geniturinária ou do trato gastrointestinal) **com lesões cutâneas características**, estamos diante da **artrite reativa**.

Espondiloartrite Axial

Como o próprio nome indica, tem predomínio do acometimento axial da coluna, podendo ou não estar associado ao acometimento periférico. O quadro de artrite geralmente é uma **oligoartrite assimétrica** (quatro ou menos articulações), geralmente acometendo grandes articulações como tornozelo, joelho ou cotovelo.

Classificamos as espondiloartrites axiais em **radiográfica** e **não radiográfica**, baseando-se na presença de destruição da sacroilíaca visível ao **raio X simples**. Importante: tem que ser no raio X; alterações apenas na ressonância magnética não entram nessa classificação.

A espondiloartrite axial radiográfica é aquela que apresenta **sacroileíte no mínimo grau 2 bilateral ou grau 3 unilateral** no raio X simples.

É uma doença muito mais comum em **homens jovens**, abaixo dos 40 anos, e tem forte associação à presença do **HLA-B27**. Principalmente em provas, costumam trazer o contexto de um homem jovem com dor lombar de característica inflamatória.

Exemplo clínico: Homem de 25 anos, HLA-B27 positivo, com dor lombar que piora pela manhã e melhora com exercício. Acordava várias vezes à noite com dor. A ressonância mostra edema ósseo nas sacroilíacas. Este é o cenário clássico de espondiloartrite axial.

No raio X de sacroilíacas, inicialmente vemos a linha escura delimitando a articulação sacroilíaca normalmente. A partir do momento que há inflamação nessa região, começa a ocorrer destruição local. Na sacroileíte grau 1 ou 2, o contorno da sacroilíaca vai ficando progressivamente mais borrado. Na sacroileíte grau 3, mal conseguimos ver a definição das articulações sacroilíacas. Na sacroileíte grau 4, praticamente não vemos mais a linha que delimita a região das sacroilíacas - há destruição completa e possível anquilose.

Artrite Enteropática

Corresponde a manifestações axiais e/ou periféricas associadas à presença de doença inflamatória intestinal.

Na **retocolite ulcerativa**, é muito mais comum o quadro periférico com artrite, dactilite e entesite, que está **associado a manifestações de atividade de doença**. Quando o paciente está com exacerbação intestinal, também piora o quadro articular.

Já na **doença de Crohn**, há predomínio de acometimento axial com sacroileíte e espondilite. Nesses casos **não há associação com atividade de doença**. O paciente pode estar com sintomas gastrointestinais controlados, mas apresentar quadro importante de dor na coluna de caráter inflamatório.

Pegadinha de prova: A associação com atividade de doença intestinal é diferente entre retocolite e Crohn!

Artrite Psoriásica

Costuma acometer homens e mulheres de forma equilibrada, geralmente pacientes mais jovens, de 20 a 45 anos. Na maioria das vezes, o **quadro cutâneo precede o quadro articular**, mas é possível ter manifestações articulares sem acometimento cutâneo - isso acontece em cerca de 15% dos casos.

Quando não há lesões cutâneas evidentes, devemos usar outros sinais e sintomas para fechar o diagnóstico: **acometimento ungueal** com pitting ungueal (depressões puntiformes nas unhas) e onicodistrofia, além de história familiar positiva para psoríase.

O **acometimento periférico** costuma ser uma **poliartrite de pequenas articulações de caráter erosivo**. O principal diagnóstico diferencial é com artrite reumatoide. Mas lembrando que a artrite psoriásica tem **acometimento das interfalangeanas distais** - isso é extremamente importante e diferencia da artrite reumatoide.

As lesões cutâneas típicas da psoríase são **placas eritematosas bem delimitadas com descamação associada**, geralmente em áreas extensoras.

Na **radiografia**, percebemos o acometimento das interfalangeanas distais bilateralmente, caracterizado pela presença de erosões que podem levar a deformidades ósseas importantes. Além disso, tendo acometimento ungueal, há maior chance de ter acometimento de interfalangiana distal adjacente.

Artrite Reativa

A artrite reativa é uma entidade um pouco diferente das anteriores. Costuma acometer homens e mulheres na faixa dos 18 a 40 anos e está associada a **infecções urogenitais ou intestinais**, principalmente pela **Chlamydia trachomatis** e pelo **Campylobacter jejuni**.

Os **sintomas articulares** (periféricos ou axiais) costumam ocorrer de **uma a quatro semanas após** o episódio infeccioso. Além da artrite, costuma cursar com lesões cutâneas características: **ceratoderma blenorrágico** (lesões crostosas geralmente em região palmoplantar) e **balanite circinada** (acometimento da região genital).

Tríade clássica cobrada em provas: Uretrite + Artrite + Conjuntivite (ou, mais corretamente, uveíte). A presença dessa tríade em jovem com história de infecção recente fecha o diagnóstico.

Mnemônico: "UAC" - Uretrite + Artrite + Conjuntivite para artrite reativa.

Tratamento das Espondiloartrites

O tratamento ocorre de maneira relativamente uniforme entre as espondiloartrites, mas com algumas particularidades importantes.

De maneira geral, utilizam-se **anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)** como primeira linha. Geralmente mantém-se o uso por no mínimo quatro semanas até reavaliação da resposta. O quadro axial geralmente responde muito bem aos anti-inflamatórios.

Nos quadros periféricos, frequentemente é necessário entrar com **medicação modificadora de doença sintética**, como sulfassalazina e metotrexato. Geralmente faz-se o teste com dois anti-inflamatórios diferentes e, na falha, propõe-se o início da **terapia biológica ou terapia alvo**.

Atenção especial: Pacientes com artrite enteropática associada a doença inflamatória intestinal requerem cautela com uso de anti-inflamatórios, pois essas medicações podem **exacerbar o quadro intestinal**. Geralmente nesses pacientes, especialmente em casos mais graves, parte-se direto para o uso de terapia biológica, sempre em discussão conjunta com gastroenterologista.

Na **terapia biológica**, temos os **anti-TNFs** (infliximab, adalimumab, etanercepte, certolizumab, golimumab) e os **inibidores da JAK** já mencionados.

Medicamentos mais específicos para espondiloartrites incluem: **anti-interleucina 17** (secuquinumabe, ixequizumabe), **anti-interleucinas 12 e 23** (ustequinumabe) e **anti-interleucina 23** isoladamente (guselcumabe, risanquizumabe).

Ponto importante: Os medicamentos têm eficácia diferente dependendo da manifestação clínica. Por exemplo, nos quadros de espondiloartrite axial, os **anti-IL23** não costumam responder tão bem. A escolha do medicamento deve considerar o padrão de acometimento (axial vs periférico) e as manifestações extra-articulares presentes.

Monoartrites

As monoartrites merecem atenção especial por incluírem a **artrite séptica**, que é uma emergência reumatológica.

Abordagem Diagnóstica

Diante de uma monoartrite, caracterizada por dor, edema, hipertermia local e geralmente hiperemia cutânea (sendo o joelho a articulação mais comumente afetada), é **obrigatório realizar punção articular com análise do líquido sinovial**. É essa análise que vai guiar o diagnóstico diferencial.

As principais etiologias de monoartrite são: **gota** (15-27% dos casos), **artrite séptica** (8-27% dos casos), **osteoartrite** (5-17% dos casos) e outras etiologias, incluindo apresentação inicial de artropatias inflamatórias como artrite reumatoide ou trauma local.

Comentário crítico: A artrite séptica é a entidade que precisamos diagnosticar com maior rapidez, pois promove dano articular em questão de horas e representa um quadro infeccioso que requer tratamento imediato.

Análise do Líquido Sinovial

A análise do líquido sinovial deve avaliar principalmente a **celularidade**. O aspecto normal é o amarelo citrino. Quando fica mais turvo, amarelado ou escuro, isso sugere processo patológico.

Em relação à celularidade e porcentagem de neutrófilos:

- **Líquido normal:** 0 a 200 células, com menos de 10% de neutrófilos
- **Líquido não inflamatório** (osteoartrite): 200 a 2.000 células, com menos de 25% de neutrófilos
- **Líquido inflamatório** (artrite reumatoide): 2.000 a 20.000 células, com mais de 50% de neutrófilos

- **Líquido infeccioso** (artrite séptica): 50.000 a 100.000 células, com mais de 75% de neutrófilos

Ponto crucial: A artrite séptica apresenta a **maior celularidade possível**, a **maior contagem de neutrófilos possível** e, muito provavelmente, **líquido turvo ou até mesmo purulento**.

Outra análise adicional essencial é a pesquisa de **cristais**, que permite o diagnóstico de gota ou doença por depósito de pirofosfato de cálcio (CPPD).

Na **gota**, encontramos **cristais em agulha de monourato de sódio** que apresentam **birrefringência negativa** à microscopia com luz polarizada.

Na **CPPD**, os cristais são **rombos** de pirofosfato de cálcio e apresentam **birrefringência positiva**.

Mnemônico: "**GRINGO PÉPO**" - **G**ota tem cristais com bi**R**efr**I**ngência **NEG**ativa; **P**seudogota (**P**irofosfato) tem birrefringência **PO**sitiva.

Artrite Séptica

O paciente manifesta-se com artrite nas características já descritas e, muitas vezes, associada a **sinais ou sintomas sistêmicos** como febre, queda do estado geral e prostração.

Os principais microrganismos são bactérias, sendo o mais comum o **Staphylococcus aureus**, seguido pelos estreptococos e, por último, pelos gram-negativos. Entretanto, qualquer microrganismo pode causar artrite séptica: micobactéria da tuberculose, fungos etc.

O **diagnóstico** é feito com história clínica compatível e análise do líquido sinovial. Por isso é tão importante, diante de monoartrite, fazer a punção.

O **tratamento** é feito com antibiótico. Como o principal microrganismo é o *Staphylococcus aureus*, a terapia é direcionada a esse agente, com uso de **oxacilina**, associada ou não a **vancomicina** (especialmente se houver risco de MRSA).

Parte do tratamento requer **punções articulares seriadas** para drenagem do líquido, como se fosse um abscesso. Em alguns casos, está indicada **artrocentese cirúrgica**, por isso é importante a avaliação conjunta com ortopedista.

Artrite Gonocócica (Doença Gonocócica Disseminada)

Uma questão especial envolve a forma disseminada de infecção por *Neisseria gonorrhoeae*, que pode ocorrer em até 3% dos casos.

Nessa manifestação, o paciente apresenta-se com **oligoartrite subaguda** (pode ter mais de uma articulação acometida), geralmente com evolução em torno de seis semanas. Algo muito característico é que, além da artrite, o paciente apresenta **tenossinovite** (visível tanto no ultrassom quanto no exame físico).

Podem ocorrer **lesões cutâneas** com pápulas, vesículas ou pústulas que costumam ser **indolores** e **poupam a face**. É importante fazer análise do líquido sinovial, puncionando a articulação com características mais inflamatórias. Raramente será identificado o gonococo - é muito difícil crescer em cultura ou visualizar o diplococo gram-negativo na bacterioscopia.

O tratamento também é com antibiótico e, nos casos de suspeita de doença gonocócica disseminada, utiliza-se **ceftriaxona e azitromicina**.

Contexto clínico típico: Paciente jovem, sexualmente ativo, sem uso regular de preservativos, com oligoartrite migratória, tenossinovite e lesões cutâneas pustulosas indolores = pensar em artrite gonocócica!

Artrites Microcristalinas

Gota

A gota resulta do depósito articular de ácido úrico. O perfil típico dos pacientes é: **homens de meia-idade**, com **síndrome metabólica** associada (obesidade, dislipidemia, diabetes) e, na história, aumento de ingestão de **purinas** na dieta (carne vermelha, frutos do mar, álcool).

Manifestações Clínicas

A gota geralmente apresenta-se em duas fases.

A **fase aguda** caracteriza-se por monoartrite ou oligoartrite com história clínica bem sugestiva: sintomas de **início rápido** (o paciente acorda de um dia para o outro com dor articular intensa) e, mesmo sem tratamento, costuma ter **resolução autolimitada em cerca de sete dias**.

Acomete principalmente **membros inferiores**, sendo muito comum na **primeira metatarsofalangeana** (podagra), podendo acometer tornozelos e também interfalângicas distais (o que não acontece na artrite reumatoide).

A **fase crônica** é caracterizada por possível destruição articular com presença de **tofós** (depósitos de ácido úrico na pele e tecido celular subcutâneo).

Pegadinha de prova: As crises de gota podem ser desencadeadas não apenas pela dieta (álcool, carne vermelha), mas também pelo uso de medicamentos como **tiazídicos**, por alterarem o nível sérico de ácido úrico.

Exames Complementares

Costumamos fazer **dosagem de ácido úrico**, que vai delimitar a meta terapêutica, mas ele **pode estar normal ou baixo** durante a crise aguda. Não é porque o ácido úrico sérico está normal que não vamos fechar o diagnóstico de gota!

Podemos usar **ultrassom reumatológico**, cujo achado característico é o **sinal do duplo contorno** (depósito de cristais sobre a cartilagem). Também podemos evidenciar tofos e o **sinal da tempestade de neve**.

Na **radiografia**, pode haver acometimento erosivo com destruição das articulações. Um achado característico são **erosões com bordas em saca-bocado**, classicamente com acometimento de interfalangiana distal.

Tratamento

O tratamento envolve o manejo da **crise aguda** e da **fase crônica/intercrise**.

Conceito importante: Antigamente havia o dogma de que hipouricemiantes (medicamentos que diminuem o ácido úrico) não poderiam ser iniciados na fase aguda. Hoje se sabe que esses medicamentos **podem ser usados tanto na fase aguda quanto na crônica**, especialmente aproveitando a janela de oportunidade do contato com o paciente.

Na **fase aguda**, usamos medicamentos anti-inflamatórios:

- **AINEs** (anti-inflamatórios não esteroidais)
- **Colchicina**
- **Glicocorticoides** (como prednisona)

Para o **tratamento da fase crônica**, usamos hipouricemiantes:

1. **Inibidores da xantina oxidase:** Alopurinol (disponível no Brasil); Febuxostate (não disponível no Brasil)
2. **Uricosúricos:** Probenecida
3. **Pegloticase** (não disponível no Brasil): Converte ácido úrico em metabólito inativo; pode ser usado em pacientes com doença renal crônica ou histórico de nefrolitíase

Atenção: Ajustar dose dos hipouricemiantes na doença renal crônica e evitar uricosúricos em pacientes com nefrolitíase.

Indicações para Iniciar Hipouricemiantes

Quando iniciar tratamento com hipouricemiantes?

Indicações para iniciar:

- ≥ 1 tofo subcutâneo
- Evidência de dano radiográfico
- ≥ 2 crises por ano

Quando **NÃO** iniciar (exceto em situações especiais):

- Primeira crise de gota
- **Exceções:** DRC (doença renal crônica), AU ≥ 9 mg/dL e/ou nefrolitíase

Ponto crucial: Não tratamos **hiperuricemia assintomática**! Pacientes com ácido úrico $> 6,8$ mg/dL sem sintomas de gota **não devem ser tratados**.

Alvos Terapêuticos

A dosagem de ácido úrico é importante no seguimento porque define a **meta terapêutica**:

- Para pacientes **sem tofos**: AU ≤ 6 mg/dL
- Para pacientes **com tofos**: AU ≤ 5 mg/dL

Falha terapêutica:

- AU > 6 mg/dL persistente
- ≥ 2 crises durante o ano
- Persistência ou formação de novos tofos

Considerar a **suspensão do tratamento** em pacientes que estão há mais de um ano sem crises e sem formação de novos tofos.

Doença por Depósito de Pirofosfato de Cálcio (CPPD ou Pseudogota)

Acomete tanto homens quanto mulheres, com tendência a ser mais comum em mulheres. O depósito articular é de **pirofosfato de cálcio** e, na história clínica,

costuma haver **história positiva para nefrolitíase** ou outros distúrbios do metabolismo do cálcio.

Manifestações Clínicas

Geralmente apresenta-se com **monoartrite ou oligoartrite aguda**, acometendo principalmente **joelhos e punhos** (diferente da gota, que acomete mais membros inferiores distais). Também ocorre em crises com resolução espontânea.

Exames Complementares

No **raio X**, podemos evidenciar **condrocalcinose** (calcificação da cartilagem), tanto em punhos quanto em joelhos. No **ultrassom reumatológico**, encontramos **pontos hiperecogênicos** na cartilagem (depósitos de pirofosfato de cálcio).

Tratamento

Ao contrário da gota, **não existe medicamento que reduza níveis de pirofosfato de cálcio**. O tratamento é apenas sintomático:

- Para quadros monoarticulares: **injeção intra-articular de glicocorticoide**
- Para crises agudas: **AINes, corticoides VO ou IM** (medicamentos de depósito)
- **Colchicina** também pode ser utilizada

Osteoartrite

Por mais que tenha ficado por último, é uma das mais importantes por ser a **desordem articular mais comum**, a que mais acomete a população geral.

Epidemiologia e Fatores de Risco

Costuma acometer **mulheres**, geralmente **acima dos 50 anos** de idade. Os principais fatores de risco são:

- **Idade:** Pacientes mais velhos têm maior incidência
- **Obesidade:** Especialmente importante para grandes articulações que suportam carga (coxofemoral, joelhos, tornozelos)

Manifestações Clínicas

O paciente queixa-se de **dor articular de característica mecânica**: pior com esforço ou movimento, principalmente ao **iniciar o movimento** (por exemplo, dor ao levantar da cadeira).

Podem apresentar queixa de edema e **rigidez matinal**, mas geralmente **menor que 30 minutos** (diferente da artrite reumatoide, que apresenta rigidez > 1 hora).

O predomínio do acometimento articular geralmente é em **mãos, quadris, coluna e joelhos** - as articulações que mais suportam carga ou são mais utilizadas.

Achados ao Exame Físico e Radiografia

A osteoartrite pode provocar deformidades, principalmente pela **proliferação óssea e neoformação óssea**, com formação de **nódulos** nas interfalangeanas:

- **Nódulos de Bouchard:** Acometimento de interfalangiana **proximal**
- **Nódulos de Heberden:** Acometimento de interfalangiana **distal**

Outra característica importante no raio X é a formação de **osteófitos** (popularmente chamados de "bicos de papagaio"), que acometem principalmente a coluna lombar, mas também podem estar presentes em outras articulações como as mãos.

Quando há acometimento da região entre **trapézio e primeira metacarpofalangiana**, temos a **rizartrose** (osteoartrite do polegar).

Achados radiográficos característicos:

- Redução do espaço articular
- Osteófitos (neoformação óssea nas margens)

- Esclerose subcondral
- Cistos subcondrais
- Deformidades

Tratamento

O tratamento requer medidas principalmente **não farmacológicas**:

Medidas não farmacológicas (mais importantes!):

- **Fisioterapia e fortalecimento muscular:** A osteoartrite é um desgaste da articulação que precisa ser compensado com músculos fortes. Por exemplo, pacientes com artrite de joelho que fortalecem a musculatura do quadríceps diminuem significativamente sintomas de dor e instabilidade.
- **Perda de peso:** Para pacientes com obesidade, a perda de peso é fundamental.

Tratamento farmacológico:

- **Anti-inflamatórios tópicos** (como diclofenaco gel): Não têm os riscos dos AINEs via oral (perda de função renal, úlceras gástricas)
- **Analgesia simples:** Dipirona e paracetamol
- **Infiltração intra-articular de glicocorticoide:** Nos casos de inflamação mais aguda

Evidência recente: Um ensaio clínico analisou o uso de **semaglutida** (medicamento para perda de peso) em pacientes com osteoartrite de joelho e obesidade. Mostrou que, com a perda de peso importante, os pacientes apresentaram redução significativa das dores e sintomas de disfunção associados à osteoartrite (SELECT TRIAL 9).

Tratamento cirúrgico: Em alguns casos pode ser necessária **artroplastia** da articulação, geralmente reservada para pacientes mais velhos, pois pacientes mais novos tenderiam a necessitar de troca da prótese no futuro.

Resumo dos Gatilhos Diagnósticos

Para finalizar, vamos consolidar os principais gatilhos para pensar em cada diagnóstico:

Artrite Reumatoide:

- Poliartrite simétrica erosiva
- Com ou sem autoanticorpos (FR/anti-CCP)
- Ausência de outro diagnóstico mais provável
- **Poupa interfalangianas distais**

Espondiloartrites:

- Acometimento axial e/ou periférico
- Se "nada mais" → Espondiloartrite axial/periférica
- Se **DII associada** → Artrite Enteropática
- Se **psoríase** → Artrite Psoriásica
- Se **infecção + lesões cutâneas** → Artrite Reativa

Monoartrites - Punção articular é OBRIGATÓRIA:

- **Homem + síndrome metabólica + monoartrite aguda 1ª MTF = Gota**
- **Monoartrite aguda + febre/sistêmicos = Artrite Séptica**
- **Oligo/monoartrite crônica não erosiva e não inflamatória = Osteoartrite**

Mnemônico final: "REAGOS" para lembrar as principais artrites:

- **RE**umatoide
- **A**xial (espondiloartrite)
- **G**ota
- **O**steoartrite
- **S**éptica

Com esse raciocínio estruturado, conseguimos abordar de forma sistemática e eficiente o diagnóstico diferencial das artrites, tema absolutamente fundamental tanto para provas de residência quanto para a prática clínica no pronto atendimento e ambulatório!

